

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format 4.0

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: FIM VAN VLIET
BIG-registraties: 89923498625
Basisopleiding: Psychologie, MSc
AGB-code persoonlijk: 94103622

Praktijk informatie 1

Naam Praktijk of Handelsnaam: NeuroMente
E-mailadres: f.vanvliet@neuromente.nl
KvK nummer: 99569930
Website: www.neuromente.nl
AGB-code praktijk: 94070028

1b. Werkt u op meer dan één locatie, geef dan de locaties en adresgegevens hieronder in:

Ravellaan 28, 3533 JN Utrecht

2. Biedt zorg aan in

Er is sprake van een overgangssituatie daarbij we zowel werken met een onderscheid in generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz als een indeling naar settings van het Zorgprestatie-model. In de toekomst zal het eerste onderscheid komen te vervallen.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

2b. Biedt zorg aan in setting 1 en vult de voorwaarden ten aanzien van de indicerende en coördinerende rol als volgt in:

De klinisch neuropsycholoog vervult zowel de indicerende als de coördinerende rol en voert de diagnostiek en behandeling zelfstandig uit.

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betreft u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

NeuroMente richt zich op volwassenen met psychische en/of cognitieve klachten in samenhang met verworven hersenletsel of neurologische aandoeningen. De praktijk biedt neuropsychologische diagnostiek en psychologische behandeling vanuit een neuropsychologisch referentiekader. Daarbij is aandacht voor de samenhang tussen cognitief functioneren, emoties, gedrag en dagelijks functioneren. Diagnostiek en behandeling worden afgestemd op de individuele hulpvraag, het cognitieve functioneren en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Behandeling kan onder meer gericht zijn op cognitieve klachten, verwerking en acceptatie, stemming, angst, trauma, coping

en het omgaan met veranderingen in het dagelijks functioneren. Waar passend worden naasten bij het diagnostiek- of behandeltraject betrokken. Neuropsychologische diagnostiek kan waar passend ook in het Spaans worden aangeboden.

3b. Cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Angststoornissen

Depressieve stemmingsstoornissen

Neurocognitieve stoornissen

Trauma en stress gerelateerde stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Regiebehandelaar 1

Naam: FIM van Vliet

BIG-registratienummer: 89923498625

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Anders: Neurologen, revalidatieartsen en andere relevante zorgverleners binnen ziekenhuiszorg en neurorevalidatie

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Op dit moment is er nog geen vaste samenwerkingspartner die het meest frequent wordt geraadpleegd. Samenwerking en afstemming vinden plaats op indicatie met betrokken verwijzers en andere behandelaren.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ik maak gebruik van mijn professionele netwerk voor consultatie, diagnostische afstemming, verwijzing, op- en afschaling of overdracht van zorg en, waar passend, intervisie. Inhoudelijke afstemming over een cliënt vindt plaats met toestemming van de cliënt.

5d. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, ggz-crisisdienst of voor fysieke aspecten huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp):

Buiten de bereikbaarheid van NeuroMente kunnen cliënten bij acute psychische klachten terecht bij de huisarts of huisartsenpost en, indien geïndiceerd, via hen bij de ggz-crisisdienst. Voor acute somatische zorg kan gebruik worden gemaakt van de huisarts, huisartsenpost of spoedeisende hulp.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: NeuroMente maakt voor acute psychiatrische en medische zorg gebruik van de reguliere regionale crisis- en spoedvoorzieningen.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Als startende vrijgevestigde praktijk neem ik deel aan twee structurele intervisiegroepen. Eén intervisiegroep bestaat uit klinisch neuropsychologen met wie ik vanuit mijn specialistische opleiding een professioneel netwerk heb opgebouwd. Daarnaast neem ik deel aan een intervisiegroep met klinisch neuropsychologen, een klinisch psycholoog en psychotherapeuten. Binnen deze groepen vindt structurele reflectie plaats op onder meer diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en het handelen als regiebehandelaar, met bijzondere aandacht voor cliënten met NAH en cognitieve stoornissen.

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Het lerend netwerk geeft invulling aan samen leren en verbeteren door structurele intervisie en collegiale consultatie. Binnen de intervisie worden casuïstiek, diagnostiek, indicatiestelling, behandelbeleid en het handelen als regiebehandelaar besproken. Daarbij wordt gereflecteerd op gemaakte afwegingen en worden ervaringen, kennis en relevante richtlijnen met elkaar gedeeld.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

<https://neuromente.nl/praktische-informatie/#tarieven>

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Anders: BIG-registratie en herregistratie als klinisch neuropsycholoog

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

[https://www.nip.nl/wp-](https://www.nip.nl/wp-content/uploads/pdfs/NIP_beroepscode_maart_2024_def.pdf?utm_source=chatgpt.com)

[content/uploads/pdfs/NIP_beroepscode_maart_2024_def.pdf?utm_source=chatgpt.com](https://www.nip.nl/wp-content/uploads/pdfs/NIP_beroepscode_maart_2024_def.pdf?utm_source=chatgpt.com)

Organisatie van de zorg

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Mijn cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling in eerste instantie bij mij terecht.

Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van de klachtenregeling Wkkgz van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Klachten kunnen worden ingediend bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) via:

E-mail: klachten@cbkz.nl

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van het klachtenformulier van de NIP-regeling. Informatie over de klachtenregeling en het klachtenformulier zijn beschikbaar via de website van NeuroMente.

Link naar website:

<https://nip.nl/klachtenregeling/wkkgz/>

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Erica Salzberg, Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het zorgproces - het traject dat de cliënt in de praktijk doorloopt

11. Wachtijd voor intake en behandeling

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: <https://neuromente.nl/praktische-informatie/#wachttijd-en-bereikbaarheid>

12. Aanmelding en intake/probleemanalyse

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de cliënt):

Aanmelding vindt plaats via het (beveiligd) aanmeldformulier op de website van NeuroMente. Na ontvangst beoordeelt de klinisch neuropsycholoog of de hulpvraag aansluit bij het zorgaanbod van de praktijk. Wanneer dit het geval is, wordt contact opgenomen voor het plannen van een intake. De intake wordt uitgevoerd door de klinisch neuropsycholoog. Tijdens de intake worden de hulpvraag, klachten, relevante medische en psychosociale factoren en eventuele eerdere diagnostiek of behandeling in kaart gebracht. Waar geïndiceerd vindt vervolgens aanvullende neuropsychologische diagnostiek en/of behandeling plaats.

12b. Ik verwijs de cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt:

Ja

13. Behandeling en begeleiding

13a. De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicierend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling en begeleiding. Ik doe dat als volgt:

Het behandelplan en de behandeldoelen worden met de cliënt besproken en gezamenlijk vastgesteld. Tijdens het traject wordt regelmatig stilgestaan bij de voortgang, ervaren veranderingen en eventuele bijstelling van de doelen. Bij diagnostiek worden de bevindingen en conclusies in een uitslaggesprek met de cliënt besproken. Naasten kunnen, indien dit passend is en met toestemming van de cliënt, worden betrokken bij diagnostiek, behandeling en evaluatie.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang van de behandeling wordt gemonitord door periodieke evaluatie van de behandeldoelen, klachten en het dagelijks functioneren van de cliënt. Waar passend worden vragenlijsten of andere relevante meetinstrumenten ingezet. De uitkomsten worden met de cliënt besproken en gebruikt om het behandelplan zo nodig bij te stellen.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten en/of medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Als standaardperiode hanteer ik een evaluatiemoment iedere drie maanden. Bij kortdurende trajecten of wanneer de aard of het verloop van de behandeling daar aanleiding toe geeft, vindt evaluatie eerder plaats.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

De tevredenheid van cliënten wordt aan het einde van het diagnostiek- of behandeltraject geëvalueerd. Dit gebeurt door middel van een korte schriftelijke of digitale vragenlijst en wordt, waar passend, tevens mondeling besproken tijdens de afsluiting van het traject.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvis, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

Omgang met cliëntgegevens

15. Omgang met cliëntgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III. Ondertekening

Naam: FIM van Vliet

Plaats: Weesp

Datum: 05-10-2026

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja